高齡長者的最後一哩路

社區醫學該如何針對人生最後10年提供醫療照顧？

網路笑話:人生成功的鐘形曲線

- 四歲時的成功是..... 沒有尿濕褲子。
- 十二歲時的成功是..... 擁有一班朋友。
- 十七歲時的成功是..... 有駕駛執照。
- 三十五歲的成功是..... 是有錢。

人生上半場是努力”獲得”

- 五十歲的成功是..... 仍有錢。
- 七十歲的成功是..... 仍有駕駛執照。
- 七十五歲的成功是..... 仍有一班朋友
- 八十歲的成功是..... 仍沒有尿濕褲子

人生下半場是力保”不失”

故事一：張老太太的下一步?

- 78歲張女士，長期服用高血壓、糖尿病與協助睡眠藥物
- 最近半年胃口不好、腹脹、體重減輕了2公斤
- 社區醫師轉介住院接受電腦斷層結果：
- **疑似第四期胃癌併肝轉移，惡性腹水及胸水**

治療建議：

1.建議胃鏡切片、腹膜或肋膜積水抽取化驗，評估化療可能性。

2.可反覆腹水抽吸或放置引流管

3.可放置人工血管或週邊中心靜脈管植入術(PICC)補充養份。

但病人不想做這些檢查。

- 張老太太沒有生育，先生已過世10年，她過去的身體狀況還算好，但自從**三年前跌倒**之後，行動較不方便，每天兩餐靠社區的送餐服務。
- **她不太想去住安養院，想在家中平安過世**。

醫療機構如何協助張女士規劃善終準備?

對張女士而言，目前最重要的是甚麼?未來會擔心甚麼事?

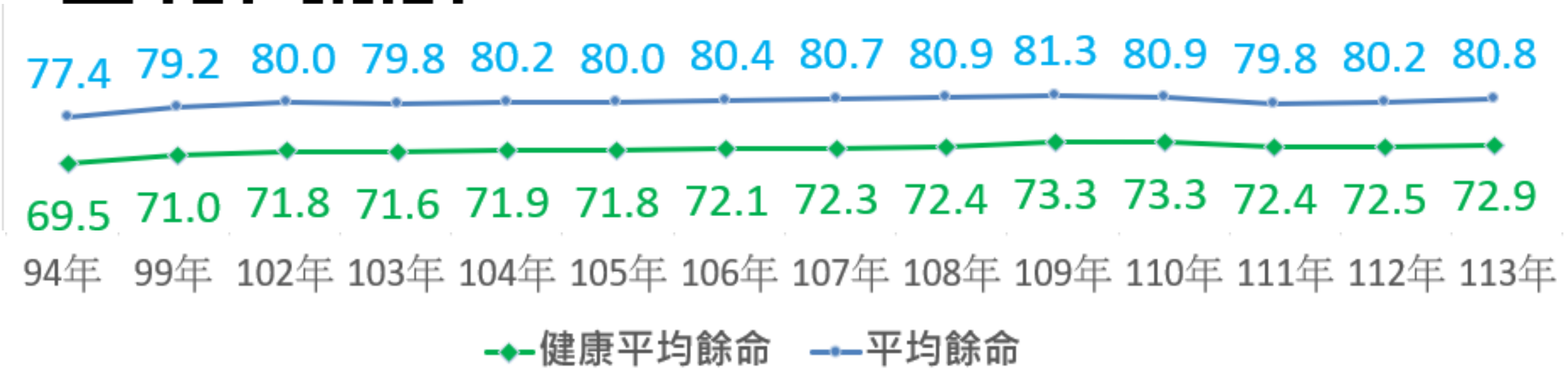
她的偏好與價值觀是甚麼?

QQ

國人平均壽命/預期健康餘命

健康平均餘命

- 人類長期照護潛在需求為7-9年(2004,WHO)
- 113年國人一生中的長照需求約為 **7.9** 年
  - 男性平均需要長照的時間為 **7.1** 年
  - 女生平均需要長照的時間為 **8.7** 年



QQ

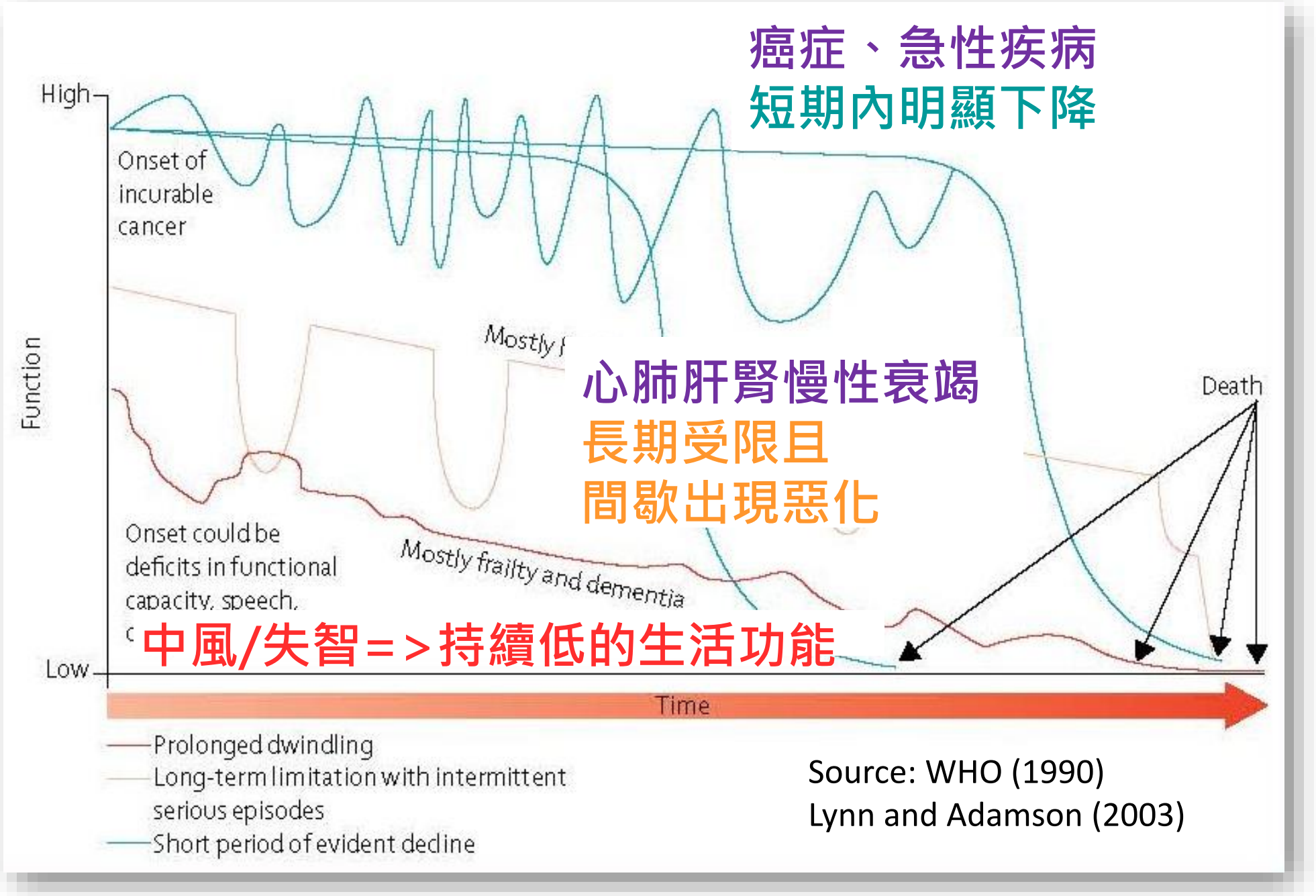
臺灣地區65歲以上老人主要死因

~ 2024

1. 惡性腫瘤(24.0%)
2. 心臟疾病(11.8%)
3. 肺炎(10.3%)
4. 腦血管疾病(6.5%)
5. 糖尿病(5.8%)
6. 高血壓性疾病(5.0%)
7. 慢性下呼吸道疾病(3.7%)
8. 腎炎,腎病症候群及病變(3.2%)
9. 失智症(2.4%)
10. 事故傷害(2.4%)

人生最後十年

如果可以選擇!?



Source: WHO (1990)
Lynn and Adamson (2003)

中華民國一〇六年三月九日 星期四 聯合報

生前交代不急救 床頭字條「不要幫我插胃管」

前副總統 李元簇 94歲辭世





前副總統李元簇因病辭世，親民黨主席宋楚瑜（右）前往李宅上香致意。
記者黃仲裕／攝影

一九九一年，當時的李登輝總統（左）頒授一等卿雲勳章給李元簇（右）。
本報資料照片

李元簇年表大事

1923年 出生

中央政治學校（政治大學前身）法政系畢業，考取高等司法官，赴關州、迴化擔任推事

【記者張裕珍、黃瑞典、祁容玉／連線報導】前副總統李元簇昨天辭世，享壽九十四歲。即任遺定

李元簇老家

愛上頭

然到苗栗旅

現當地風土

居頭份，一住

鄰居們說

子，因喜愛

花園；近年

入屋，讓李

近年飽

李元簇近

都得坐輪椅

醫院執行長

、坐骨神經

要到醫院洗

莊繼光說

與台北，大

兒子每周六

大兒子回台

食欲也特別

洗腎，當時

揮手再見」

昨天李家

居苗栗縣頭份市的李元簇，近年身體每況愈下，主治醫師莊繼光說，近月李吞嚥困難，插上胃管灌食，但一周後被李拔掉，並在床頭貼了一張署名的字條，「不要幫我插胃管」，希望走得尊嚴。

老天鵝娛樂

疫情中・最值得信賴的報紙

李登輝住院173天 生命拔河

昏睡半年 曾文惠輕撫喚老伴



夫人探視



蘋果日報 APPLE DAILY



全球疫情掃描

確診 1676萬172例 (較21萬7079例)

死亡 66萬790例 (較5798例)

台灣 確診467例 (無新增)

死亡 7例(無新增)


李登輝病史
・心臟病 ・肺結核
・糖尿病 ・曾患大腸癌
喝牛奶嗆到
引發肺炎
住院治療
病情
驚傳變化
緊急用藥起色
持續治療
家人.隨扈.幕僚陪伴
2020/02/08
2020/07/28
2020/07/30
1923-2020.7.30

「生比死好，但每一個人終究得面對死亡。這個問題是許多正值壯年的人不願意去面對的。但89歲的我沒必要迴避這個問題。

我關注的是：我會怎麼離世？會不會是冠狀動脈中風，迅速了結一生？還是腦中風，陷入半昏迷狀態，臥病在床好幾個月？這兩種方式之中，我寧願要盡速了結。」

「不久前，我做了預立醫囑，意即**如果我必須靠插管才能進食，而且不太可能復原或再次自行走動，那醫師就得為我拔管，讓我能盡速離世。**我在一位律師朋友和醫師的見證下，簽下這份指示。

「如果不簽下這份醫囑，**醫師會窮盡一切方法去阻止必然要發生的事**，我見過太多類似情況了。我太太的姐夫楊玉麟病逝之前插著管子，在家躺著。他的大腦漸漸沒有意識，但醫師還是讓他繼續撐了好幾年。

這又有什麼意思呢？」』

「醫師或親屬通常會認為，他們**理應設法延長病人的壽命，這我無法苟同**。萬事終將有盡頭，我希望自己人生的終結，會來得迅速且毫無疼痛。我可不想變成殘廢，半昏迷臥床，鼻孔插著管子直通入胃。

那樣的情況**不過只剩下軀殼而已**。」

2013年「李光耀觀天下」《One Man's View of the World》書摘

高齡長者的心聲

88%~93%的老人寧願死亡，也不願讓自己陷入慢性昏迷、插管或放置呼吸器的狀態

~ Yung VY, 2010

80 歲以上住院老人對侵入性治療的接受度

- 70%渴望獲得舒服的照顧遠甚過於延長生命
- 但卻有63%在他們死亡之前接受超過1 種以上的維生治療措施

~ Somogyi-Zalud E 2002

張老太太也這樣想嗎？

國際公認的善終(Appropriate Death)

- 瞭解自己死之將近
- 心平氣和接受
- 後事交代安排
- 時間恰當能有準備
- 去世前身體舒適性

本土善終(Good death)

- 身體平安
- 心理平安
- 思想平安

~ 趙可式博士對癌末病人訪談

社區資源如何
支持生命末期
臥床長者?

善終

預立醫療決定
協助盡早討論
擬定照顧方向

如果可以選擇，
希望自己的生命終點~



在醫院
過世!



在急診
過世!



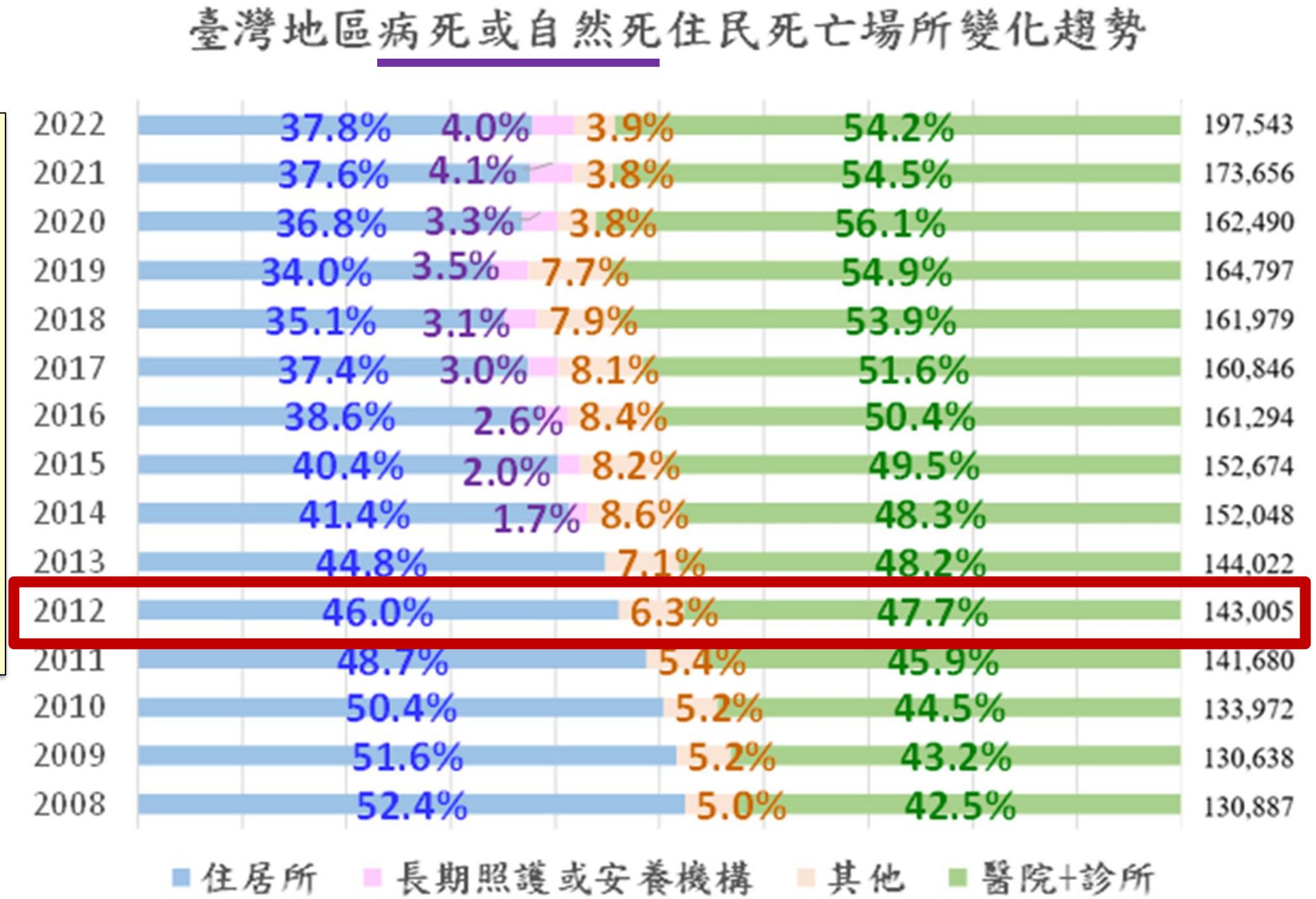
在自宅
過世!



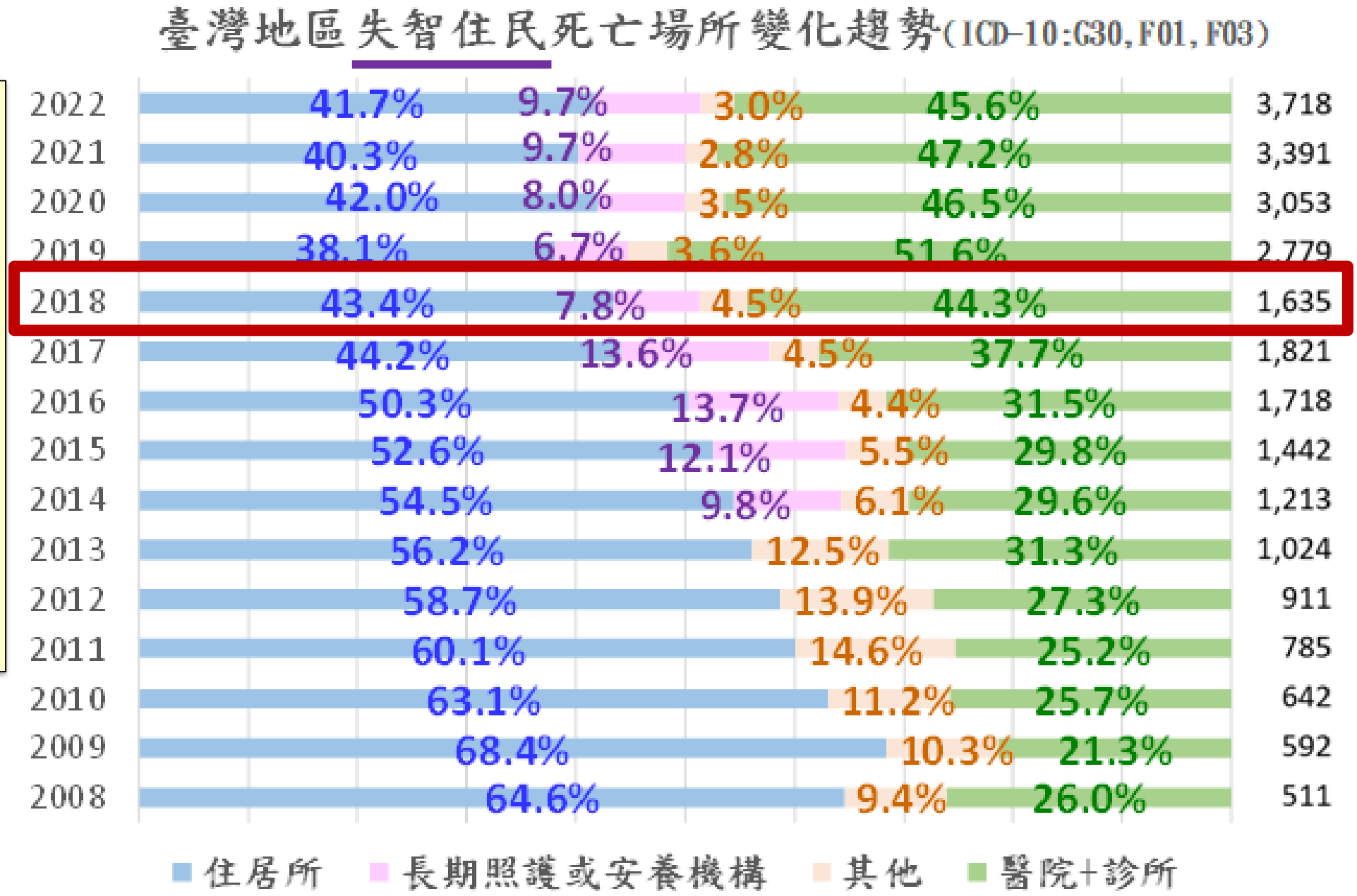
在機構
過世!

臨終彌留返家

臺灣所有病人在家過世的比例自2012起減少，在長照機構過世的比例較其他國家低許多。



臺灣失智病人在家過世的比例自2018起減少，在長照機構過世的比例較其他國家為低。



多數癌末病人在醫院離世，但有80%希望在家善終

- 家人是影響的關鍵因素
- 病人/家庭端面對：癌症末期常會出現疼痛、出血、喘、無尿、排便困難...
  照顧上產生很大的困難、害怕及不安...

痛點1 不知道

- 不知道會發生什麼事
- 不知道在家照顧的準備

痛點2 不安心

- 不知道在家如何照顧
- 不知道社區資源是否足夠

痛點3 不預期

- 無法預測病情變化
- 不知道怎麼照顧及應急處理，常措手不及。

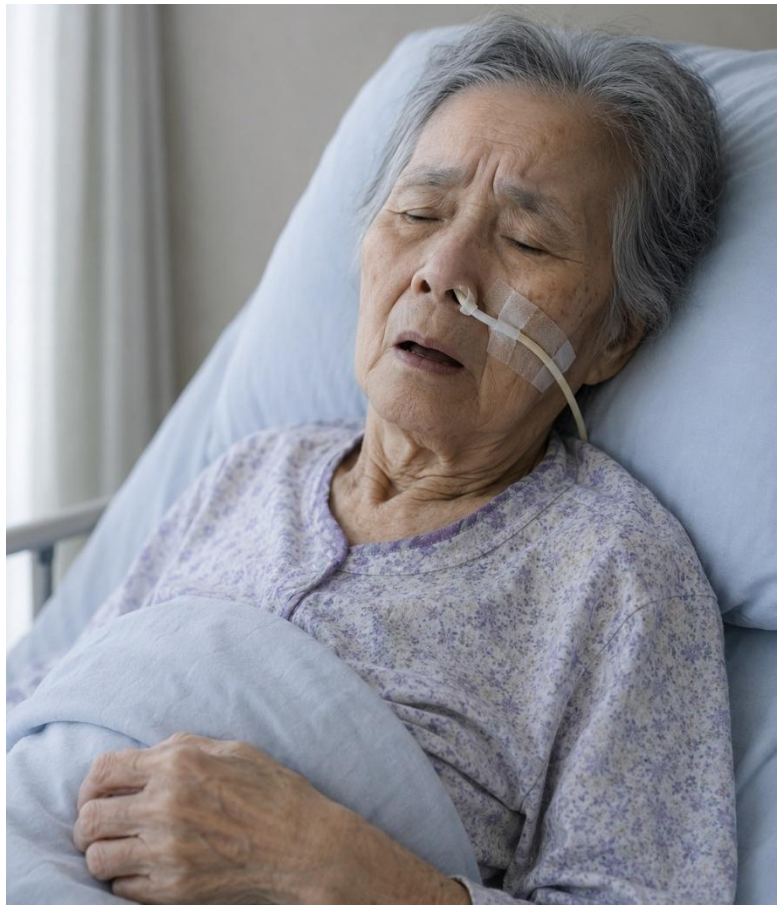
3個「不」讓生命最後一程在往返
急診奔波中流失很多重要事...

想要好走，連119都不能叫

作者：黃惠鈴 2014-11-12



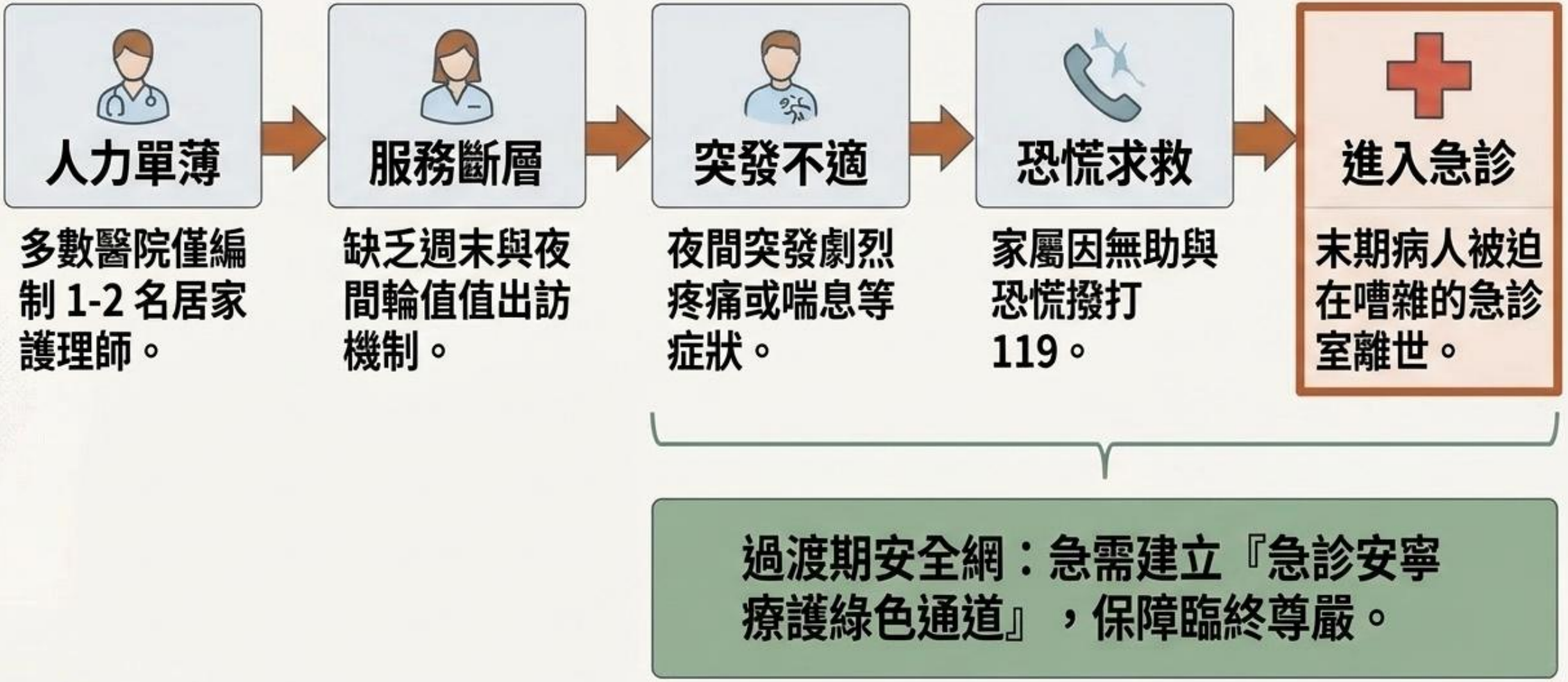
常見高齡個案生命最後的一哩路



88歲女性，失智超過8年，有多重慢病
最近半年開始倚賴鼻胃管灌食

- **HF** 心衰竭 (Heart Failure)
- **CKD** 慢性腎臟病 (CKD)
- **D** 失智症 (Dementia)
- **AP** 反覆吸入性肺炎 (Recurrent Aspiration Pneumonia)

系統性困境：為何善終之路走向急診？



「每一站都有專業人員，卻沒有人對整段旅程負責。」

照護斷層的代價：高度依賴急診與住院

末期病人不是沒有接受照護，而是照護集中在錯誤的場域。



頻繁轉換的「轉運站」模式

開闢綠色通道：推動急診安寧療護的急迫性



安寧居家團隊多僅於平日白班運作

預講的綠色通道



急診室必須成為接住「預期在醫院過世病人」的最後一道安全網。

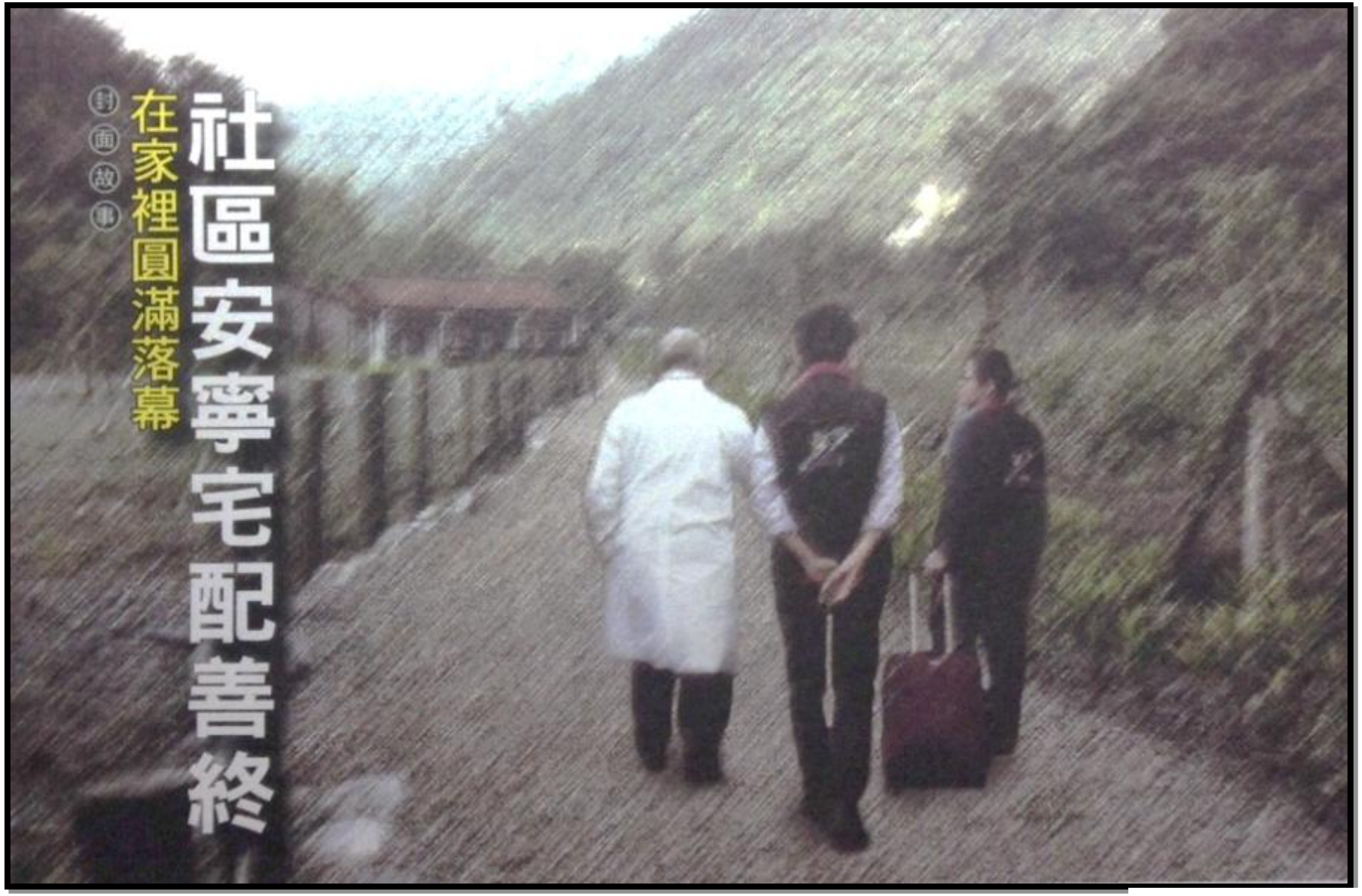
政策重構：從「病床配置」轉向「區域網絡」

過去（舊思維）

- 規劃單位：以「醫院層級」配置資源
- 介入時機：單向的末期出院轉介
- KPI指標：增設了多少「安寧病床」與死亡地點是否在家

未來（新典範）

- 規劃單位：以「醫療生活圈」配置照護責任
- 介入時機：提早辨識與長照／醫療共同介入
- KPI指標：是否具備 24 小時雙向緊急應變與合理交通距離內的團隊覆蓋



台大金山分院安寧團隊

末期病人的期盼 ~



幾年的努力下來，現在在金山分院，甚至有病家主動打電話來預約：「要跟你們照顧過的〇〇〇一樣，**就照他那樣，能順順的走就好**，請幫我們來做居家照顧，病人想在自己家中安詳往生。」

末期病人的期待

- 不要
  - 痛苦不堪
  - 無效延長
  - 家累負擔

- 要
  - 自己能控制
  - 與家人一起

Singer et al.
JAMA 1999.

QQ

高齡照顧的重要概念

- in their own homes：盡可能支援老年人及其照顧者，使他**待在自己家中的時間能愈長愈好**。
- continuity of care：盡可能**銜接**醫院的急性照顧與社區的醫療服務。
- wide range of options：發展**不同的照顧方案**供老年者做選擇。
- links between those services：增加對老年人及失能者照顧**資源的連結**。
- community geriatric assessment teams：發展**社區老人評估及照護團隊**以提供適當服務。

社區常見衰弱老人症狀

- 體重減輕：
  - 過去一年內體重減輕達5%
  - 或體重下降超過4.5公斤（10磅）
- 虛弱：握力下降、走路速度變慢
- 疲倦：經常覺得自己甚麼事都無法做
- 疼痛、憂鬱與跌倒

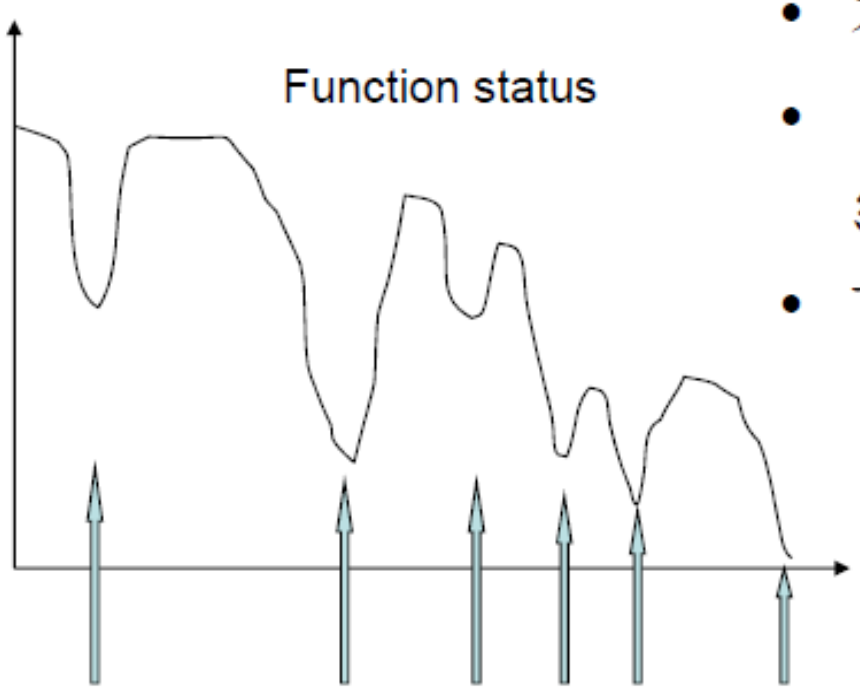
各類疾病末期的定義？

- 許多非癌疾病末期時間相當漫長以年計算

何時是 放手時機？	何時該 繼續搶救？

- 瞭解病人偏好意向，
  才能打造善終計畫！

非癌症緩和醫療的介入時機



- 不易定義「末期」
- “Relapse-remit pattern”，總是期待能再”進步”
- 下滑的大趨勢沒有被察覺

介入時機：視「**需求**」而定

(Based on “**Need**” rather than “**Survival**”)

家人知道病人的意願嗎？怎樣確認？

- 老人和代理人的關係型態（type of elder-proxy relationship）和家庭衝突（family conflict）會影響老人和代理人
  - 子女是最無法正確預測老人想法的人。
  - 配偶是最正確的預測者

Parks SM, Winter L, Santana AJ, et al.
J Palliat Med 2011; 14(2):179-84.

動態的老年緩和照護過程

- 面對老化最終結果：「死亡」的調適力

早期	中期
盡量維持自主**獨立** 盡量維持**社交**活動 **價值觀**與**偏好**的討論	加強症狀控制與復健 協助**家屬**學習照護技巧 居家環境調整
晚期	
目標導向臨終照護 減緩及預防受苦 尊嚴過世，減少住院機會	

有緩和療護照護需求民眾的辨識

SPICT-TW™

Supportive and Palliative Care Indicators Tool (Taiwan)

1. SPICT-TW使用的核心目標

- 是當個人整體健康狀況有變動、出現健康惡化加速的風險，或是照護與支持的需求增加時，**能幫助及時辨識並評估緩和療護的需求**，方便討論合適的照顧計畫
- 協調溝通社區或醫院中跨領域不同專業的醫療或相關照護人員。

https://www.spict.org.uk/the-spict/spict-tw-taiwan/

促成臨終病人在家往生的要點

- 足夠的護理照顧
- 晚上陪伴的服務

1或多名家屬陪伴臨終病人

（美國部分保險提供每日8小時全時護佐到病人家中協助）

安寧居家團隊

- 好的症狀控制
- 有能力且願意參與的基層醫師
- 有專業安寧緩和療護團隊支援
- 有足夠支持的經費/一般大眾臨終教育

QQ

健保居家整合照護計畫



居家醫療(S1)

重症居家(S2)



呼吸居家訪視(S4)



安寧居家(S3)



中醫居家訪視

其他居家計畫



健保機構(安寧)居家專業訪視



在宅醫療急症照護

張老太太的善終歷程

住院期間安排預立醫療照護諮商（ACP）協助她了解現況與預後，並依意願立下AD及擬定在家善終的照護計畫，包括：

1. 出院後銜接安寧居家訪視，協助疼痛、喘、腹水等症狀緩解；提供陪伴與生命回顧等心理與靈性支持：，協助她面對死亡焦慮。
2. 社區長照支持：由社區居家照顧服務員提供居家身體照顧與生活輔助，維持基本生活品質。

1. 某天張老太太病情突然有變化(喘，冒冷汗)。
2. 安寧居家緊急訪視，發現病人意識清楚但血壓偏低，病人無意願就醫~遂依其意願處方止喘藥物，並聯絡教會的弟兄們前來陪伴。
3. 病人在隔天清晨，於禱告聲中，安詳在家離世。

居家安寧照護之優點

- 有歸屬感（家、家人、家中的角色）
- 熟悉的溝通（語言與坦誠互動）
- 安全感（自我控制感）
- 家人的陪伴/家庭是最熟悉之療養場所
- 民俗習慣/ 死亡教育
- 減少家人往返奔波/避免機構化影響
- 維持家庭結構、功能之完整性
- 增加病床流動性與利用性
- 節省社會醫療資源成本

在機構接受安寧照護也具備這些優點!!

臺灣65 歲以上住機構約8.4萬人(佔2%)

長照機構住民的特性

1 年齡、多重共病與失能

機構住民多為高齡長者，常有慢性疾病。他們需要全面的照護。

2 有身心社靈多層面需求

住民有生理、心理、社會及靈性層面的需求。緩和照護是重要的一環。

3 其緩和照護需求常被忽略

歐美國家常使用衰弱老人量表和SPICT量表評估住民狀況。以助於制定未來照護計劃。



故事二：石伯伯的生日願望



主任：我只求最後可以平平安安在榮家過世

機構單身住民：石伯伯(88歲)

- 88歲的石伯伯，已入住榮家18年。
- 8年前曾發生小中風，病人尚有糖尿病及慢性肺阻塞。
- 近兩年因肺炎，下肢反覆感染多次住院治療，最近糖尿病腎病變惡化，但病人無意願接受透析治療。
- 今年的生日願望：伯伯希望可以在榮家平安回天家，不要再送到醫院去急救。

臺灣末期病人並不常在長照機構過世

領導者因素

- 態度信念/利害關係
- 政策誘因/法律糾紛
- 與安寧團隊合作關係

工作人員因素

- 信念/知識
- 情感/心理負擔
- 人力不足/獎勵補助

家屬因素

- 臨終送醫院的迷思
- 擔心與互信不足
- 其他住民/家屬反彈

住民疾病因素

- 疾病軌跡
- 未及早啟動ACP對話
- 安寧居家團隊支援

促成臨終病人在**機構**往生的要點?

- 足夠的護理照顧
- **晚上陪伴的服務**

(美國部分保險提供每日協助

機構照顧者同時要照顧其他14位住民!

安寧居家團隊

- **好的症狀控制/ 居家舒適包及藥品**
- 有能力且願意參與的基層醫師
- 有專業安寧緩和療護團隊支援
- 有足夠支持的經費/一般大眾臨終教育



榮民安寧緩和全程照護網絡計畫

Integrated Hospice Palliative Care Network for Veterans in Taiwan

(IHPCNVT)

中華民國103年6月 編印

榮民安寧全程照護網絡

親切、安寧、連繫

Integrated Hospice Palliative Care Network for Veterans

安寧共同照護服務

急性病房
總院或榮分院
安寧病房

家 (榮家)長照機構

安寧居家療護服務

引入國際機構住民資料包含照護偏好

Advance Directives/Goals of Care

☐ Full Code ☐ DNR (Do Not Resuscitate) ☐ DNI (Do Not Intubate)

☐ DNH (Do Not Hospitalize) ☐ No Artificial Feeding

☐ Comfort Care ☐ Hospice Care

☐ Other *(specify)*: _____

Were goals of care discussed during this hospitalization? ☐ No ☐ Yes *(specify)*

Full Code	依照醫療常規
DNR (Do Not Resuscitate)	不要復甦急救
DNI (Do Not Intubate)	不要插管
DNH (Do Not Hospitalize)	不要住院
No Artificial Feeding	不要人工營養餵食
Comfort Care	舒適照護
Hospice Care	安寧照護

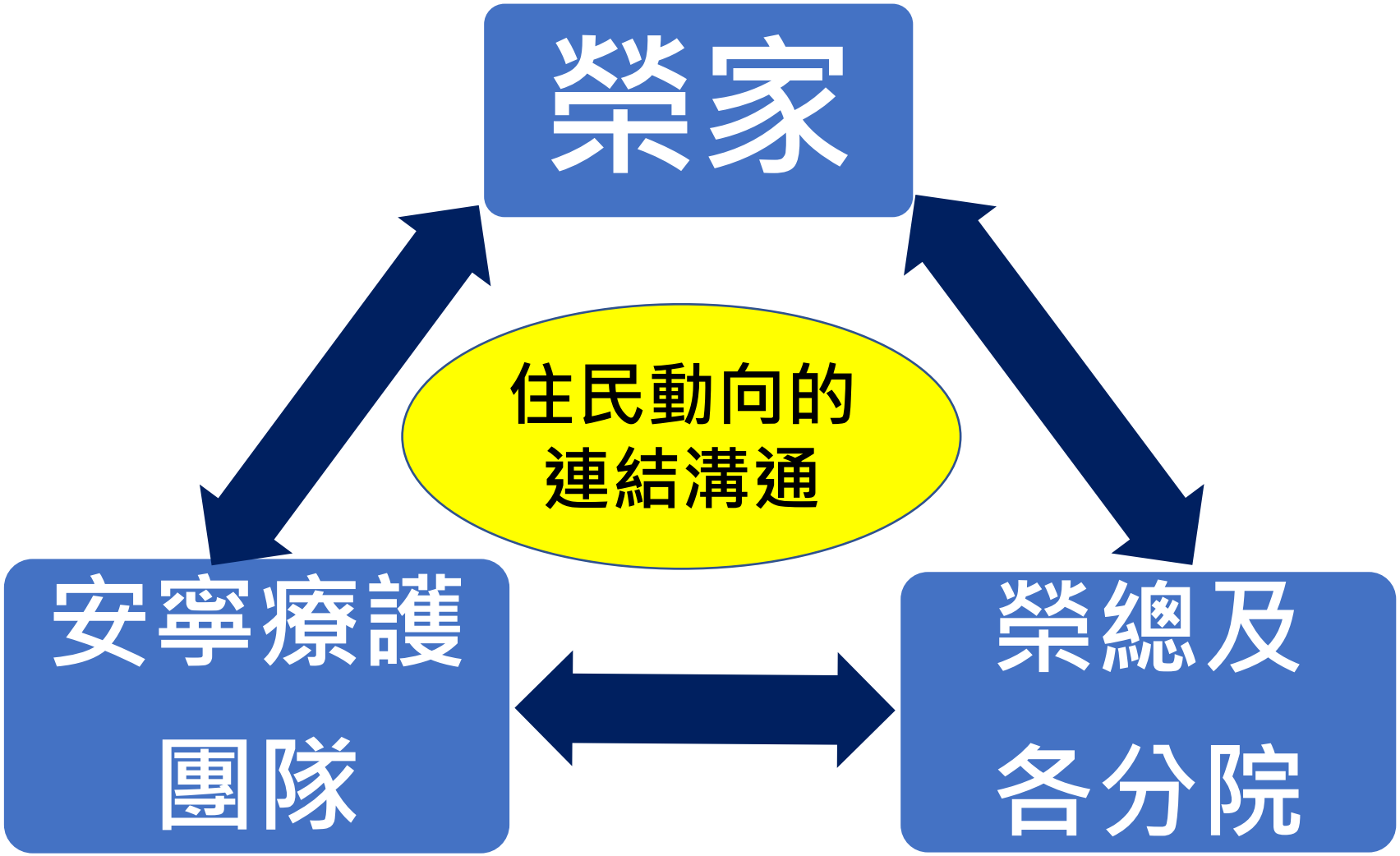
安寧居家舒適照護箱



臺北榮民總醫院舒適處方

病人姓名：_____ 開立日期：_____ 醫師簽章：_____

	處方藥物 (請勾選☑ 表示開立處方)	使用方法
發燒	☐ Acetaminophen (500 mg); p.o. ☐Cataflam (25mg); p.o ☐Diclofenic (12.5mg) supp.	耳溫大於____度，每___小時使用一顆
疼痛 喘 呼吸困難	☐Morphine (15mg);p.o. ____ mg	需要時每___小時使用口服 _____mg 無法口服時，可磨粉放舌下
	☐Fentanyl patch 12ug /片	每三天更換一片
	☐Painkyl buccal film 200 mcg/片	需要時每 6 小時貼於濕潤口腔黏膜內
	☐ Dexamethasone (5mg/ml/amp)	需要時每____可皮下注射_____ml
口水分泌物多 死亡嘎嘎聲	☐*Scopolamine 1.5mg/片	貼於耳後，每次一片，可使用三天
便祕	☐* Bisacodyl supp. (10mg)	若三天未排便可每次使用 1 粒.
噁心感	☐ Haloperidol (5mg);p.o.	需要時每___小時口服 0.5~1 顆
	☐ Binin-U (5mg/ml/amp);SC	需要時___小時皮下 0.2ml, 或持續皮下 0.5-1ml/day
	☐ Olanzapine (10mg); p.o. (Zyprexa®)	需要時每日口服 0.5~1 顆
	☐ Dexamethasone (5mg/ml/amp)	需要時每日皮下注射_____ml
煩躁不安 瞻妄 失眠	☐Risperidone (1mg/ml) (Risperidal®)	需要時每_____小時口服_____ cc
	☐ Binin-U (5mg/ml/amp);SC	視需要每_____小時皮下 0.2ml, 或持續皮下 0.5-1ml/day
	☐Haloperidol (5mg) (Haldol®)	需要時每____小時口服 0.5~1 顆
	☐Lorazepam (0.5mg)(Ativan®)	需要時每____小時口服 0.5~1 顆
	☐Midazolam (7.5 mg)(Dormicum®)	需要時每____小時口服 0.5~1 顆
	☐Midazolam(1mg/ml, 5ml/amp)(Dormicum®)	需要時每____小時皮下 2.5ml, 或持續皮下 10ml/day
癲癇 肌陣攣	☐Midazolam(1mg/ml, 5ml/amp)(Dormicum®)	需要時每_____小時皮下 2.5ml, 或持續皮下 10ml/day
	☐Clonazepam (0.5mg) (Rivotril®) ☐Diazepam (2mg) (Valium®)	需要時每____小時口服 0.5~1 顆
急性心絞痛	☐Nitrostat 0.4mg 舌下錠	需要時舌下含服每次使用 1 錠，每五分鐘使用 1 錠最多 3 錠。


榮家
住民動向的
連結溝通
安寧療護
團隊
榮總及
各分院

當某天石伯伯病情突然有變化時

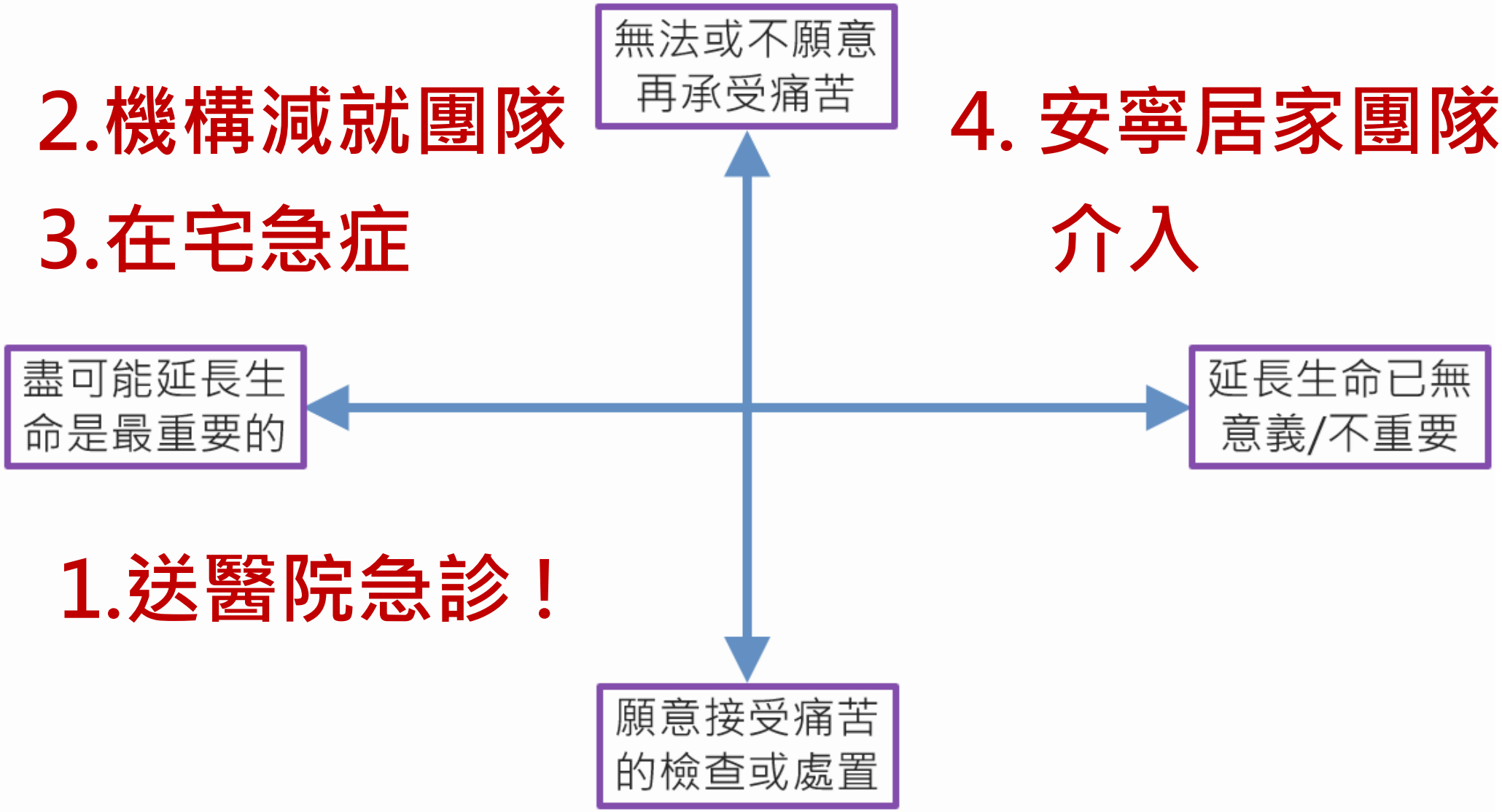
08:10 37.5度、呼吸21、 111/68(77)、94%，食慾欠佳，午餐吃半碗，採舒適餵食，身上皮膚觸摸溫暖，四肢無水腫，下肢足背動脈2+，上呼吸道症狀存，快篩:陰性。

12:27 38.3度、呼吸23、177/103(94)，94%，餵藥不易，

12:35 意識清楚但精神較倦怠，病人無意願就醫~

1. 送醫院急診?
2. 通知減少就醫方案專責機構?
3. 通知在宅醫療急症團隊?
4. 轉介安寧居家團隊小組?

如何決定比較符合石伯伯的生日願望?



2.機構減就團隊

4. 安寧居家團隊介入

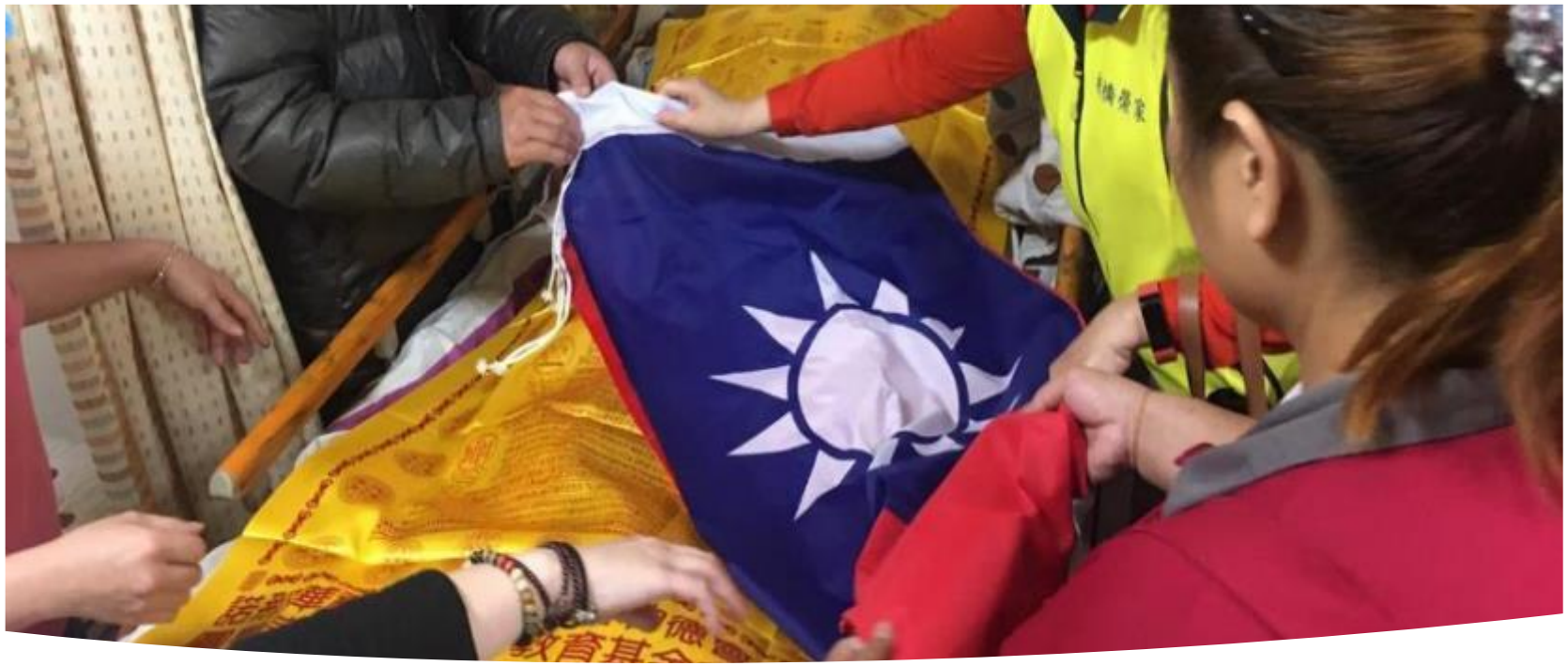
3.在宅急症

1.送醫院急診！

在自己的家 尊嚴善終

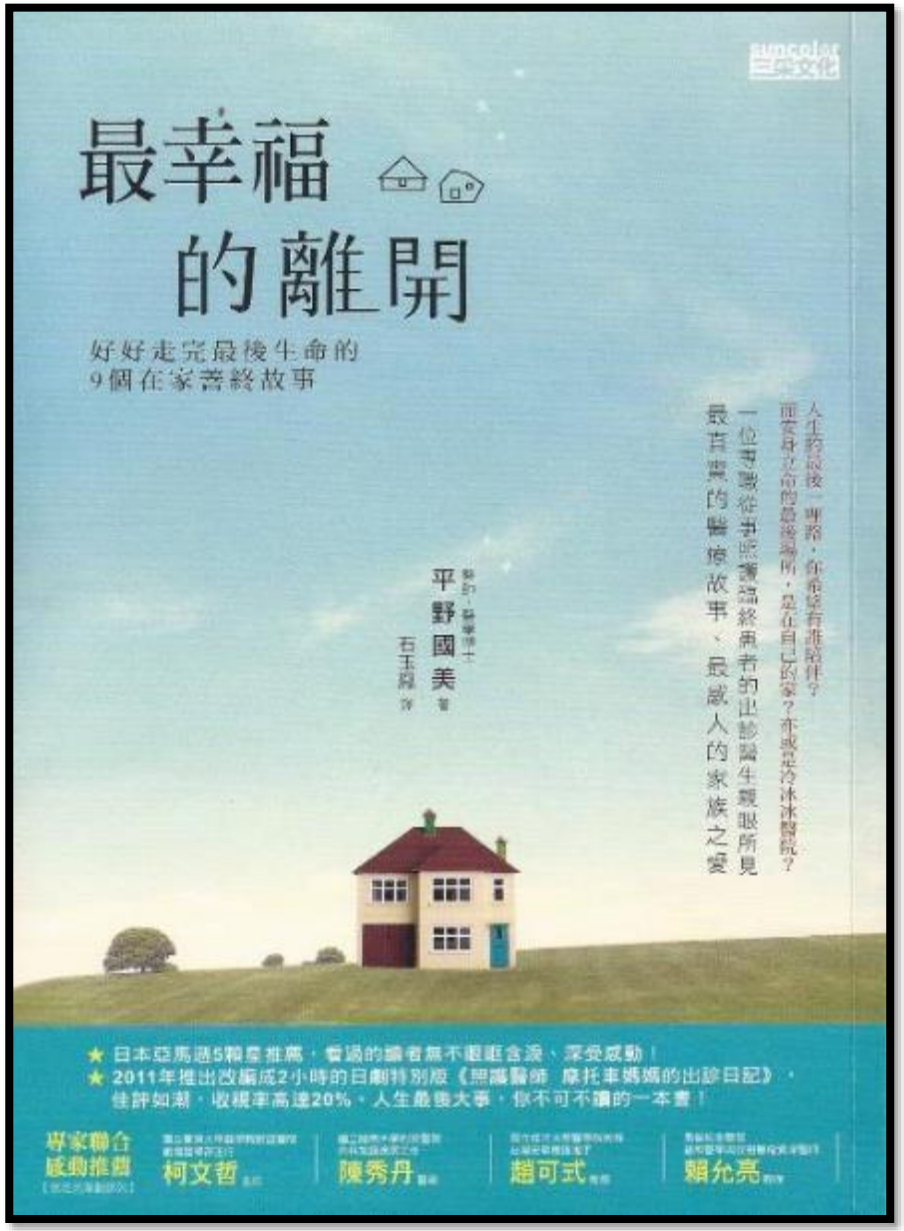


板橋榮家居家安寧



榮家安寧緩和療護影片

https://www.youtube.com/watch?v=9Li12M6ongY



祈願~

每位長輩，當步入生命末期時，可依自己心願，在期待的處所，

擁有~

最幸福的離開!

各國社區緩和照顧模式介紹

- 英國Macmillan Cancer Support

  https://youtu.be/lqNiTEU6Lqk (3:47)
- 北愛爾蘭臨終關懷-日間安寧照護中心服務

  https://youtu.be/TWPtlqRQ4Mg (2:10)
- 澳洲機構安寧居家照護服務

  https://youtu.be/2KGwSOApzkw (2:24)
- 紐西蘭社區安寧院介紹

  https://youtu.be/68m655yrJgI (6:29)
- 荷蘭博祖克居家照顧模式（BUURTZORG Model）

  https://youtu.be/DfqJgETpYHo (4:08)

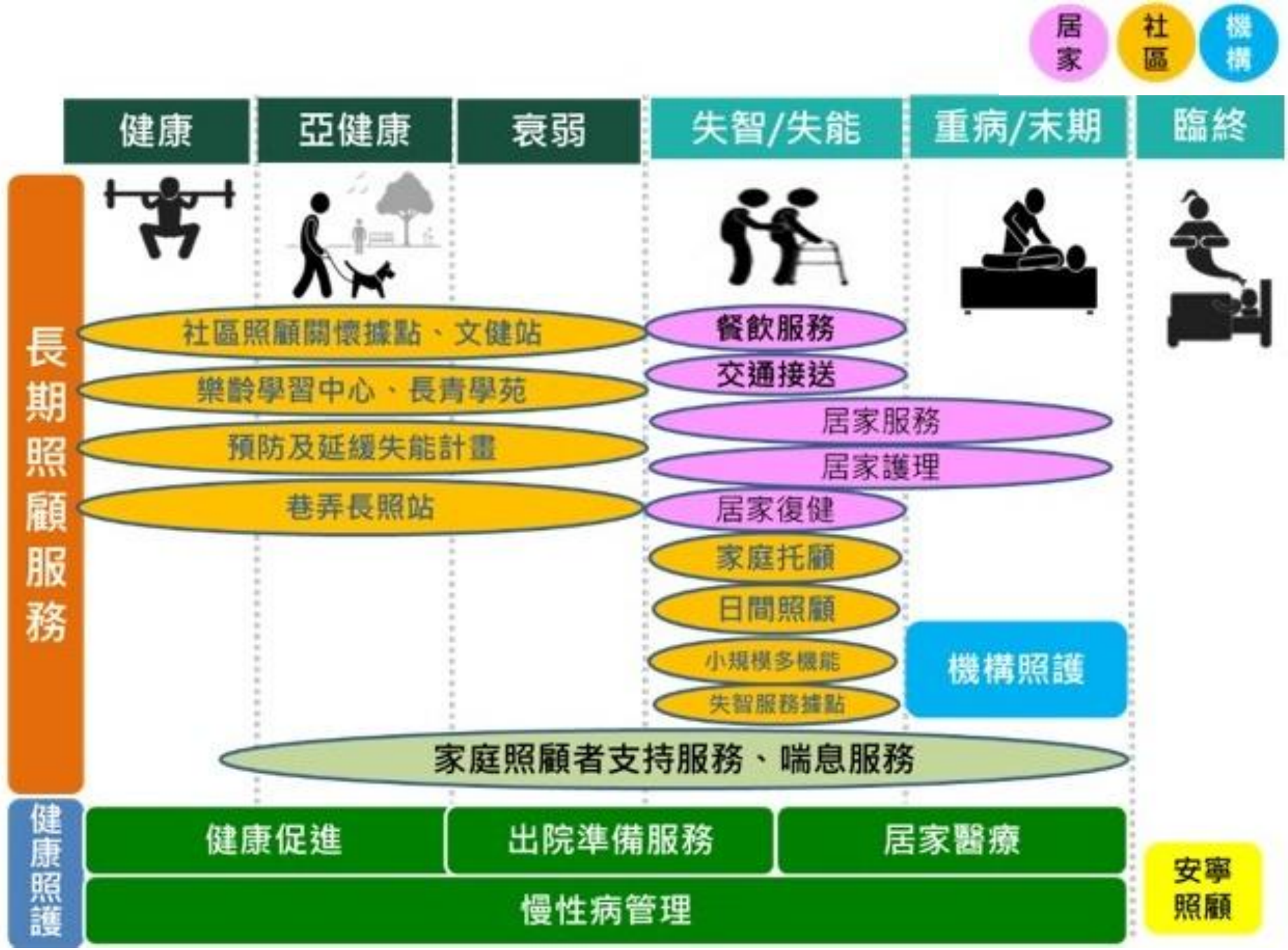
  https://youtu.be/vAilHjc_m-g (4:55)
- https://www.seinsights.asia/article/3290/3324/3433

課後反思：當你年邁時，想接受哪一種社區照顧服務?

- 門診服務模式
- 在宅服務 (Domiciliary service)
  - 居家照護……
- 社區服務 (Community)
  - 日間照護，社區醫療服務…
- 機構服務 (Institutional)
  - 老人村 (retirement villages)
  - 在宅服務 (domiciliary service)
  - 群聚照顧 (congregate care)
  - 護理之家 (skilled nursing home)
  - 養護所 (foster home)

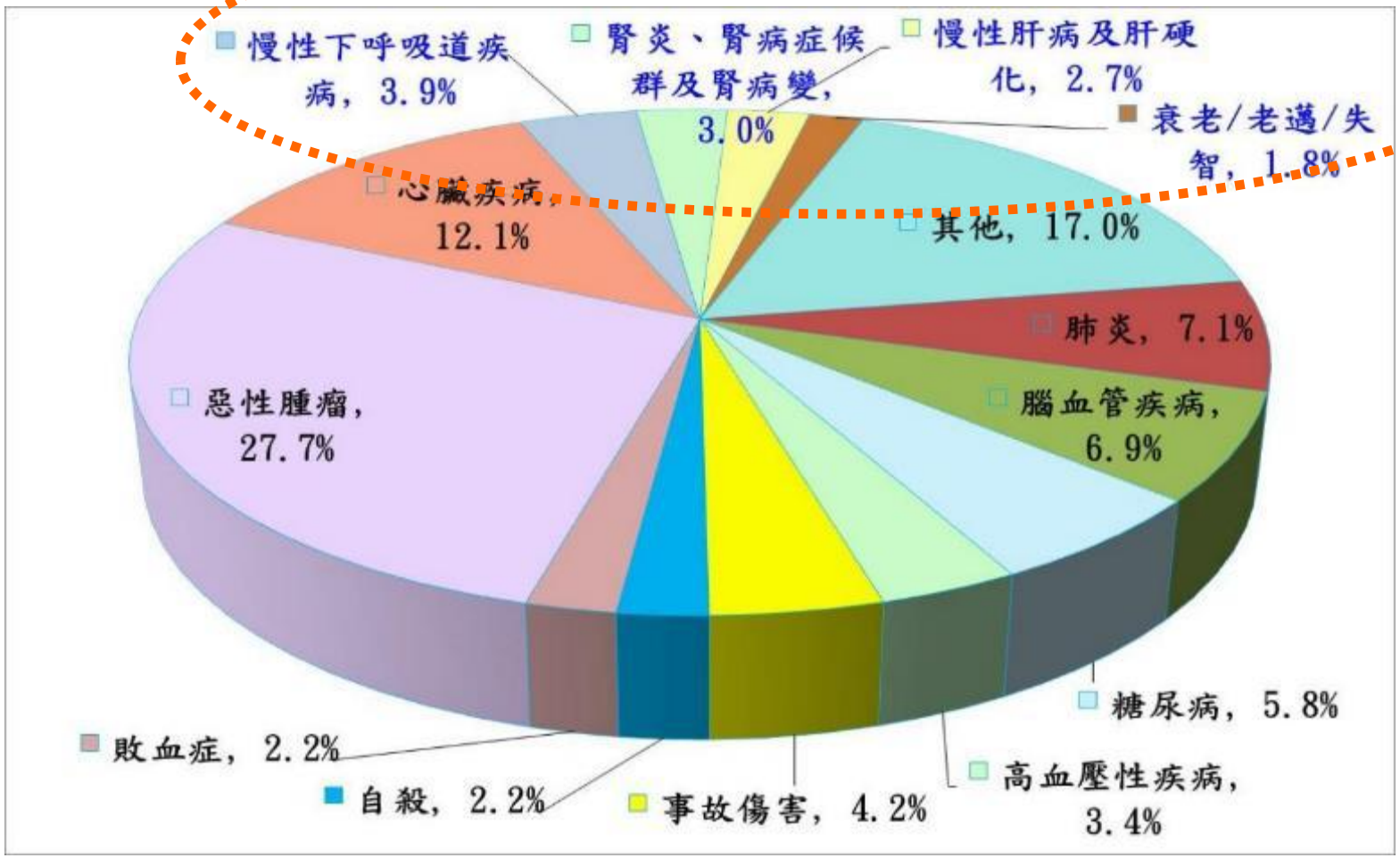

活著，是最好的禮物
善終，是最美的祝福
感謝大家
聆聽指教!

課後参考資料


居家
社區
機構
健康
亞健康
衰弱
失智/失能
重病/末期
臨終
長期照顧服務
社區照顧關懷據點、文健站
樂齡學習中心、長青學苑
預防及延緩失能計畫
巷弄長照站
餐飲服務
交通接送
居家服務
居家護理
居家復健
家庭托顧
日間照顧
小規模多機能
失智服務據點
機構照護
家庭照顧者支持服務、喘息服務
健康照護
健康促進
出院準備服務
居家醫療
慢性病管理
安寧照顧

近年臺灣主要死因分析

重要器官衰竭11.4%



總死亡人數約20餘萬人



在宅急症照護(Acute care at home)
在家住院 (Hospital at Home, HaH)

行動受限無法外出就醫病患

擴大推動**居家醫療照護整合計畫**：
檢討居整計畫、安寧居家療護，並推動**在宅急症照護**模式，擴及長照機構住民，鼓勵醫療團隊走入社區提供**居家醫療**全人全程照護。

結合**長照機構住民減少就醫方案**：
銜接**長照服務**，逐步推動論人方案(ACO)

照護階段：居家醫療 → 重度居家醫療 → 安寧療護

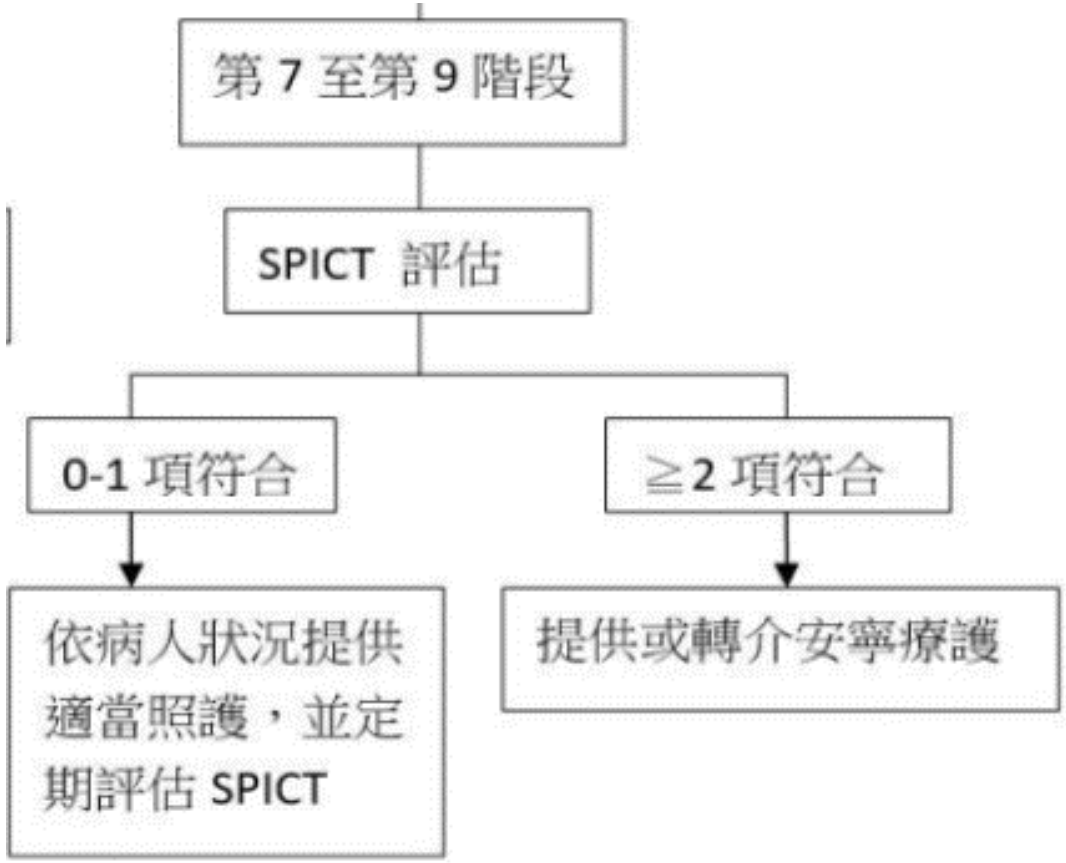
擴大全人全程照護

- 家庭醫師需充分掌握病患完整健康資料(如疫苗施打、預防保健等)
- 加強政策誘因，導入**在宅急症照護**，銜接長照資源

臨床衰弱量表中文版(Clinical Frailty Scale)

臨床衰弱量表			
1.非常健康	健壯、活躍、精力充沛並充滿動力，定期運動且處於所在年齡階段最健康的狀態	6.中度衰弱	所有室外活動和家務均需要協助，在室內上下樓梯常有問題，洗澡需要幫助，穿脫衣服可能也需要輕微的協助
2.健康	無明顯疾病症狀但不比等級1的人健康，經常運動，偶爾活躍（例如 季節性）	7.嚴重衰弱	無論原因（身體或認知功能下降）而導致生活完全無法自理，但身體狀況相對穩定而無死亡的風險（6個月內）
3.維持良好	患有疾病但控制良好，除了規律行走外，平常並不活躍	8.非常嚴重的衰弱	生活完全無法自理，接近生命終點，即使得到輕微的病症也難以康復
4.脆弱較易受傷害	日常生活不需仰賴他人，但活動常因身體的症狀而受限，常見的主訴為"行動緩慢"和（或）白天時覺得疲憊	9.末期	接近生命終點，這個期別包含不符合衰弱定義但預期壽命少於6個月的人
5.輕度衰弱	明顯的動作緩慢，工具性日常生活活動（如理財、搭乘交通工具、重型家務、服藥…）需要幫助		

衰弱老人安寧緩和療護需求篩檢



王玥心等。老人衰弱症的評估與預後。基層醫學。第三十四卷第九期252-257頁。
翻譯自 Rockwood K, Song X, MacKnight C, et al. CMAJ.2005;173:489-495.

衛福部2022年老人狀況調查報告

65 歲以上住機構約8.4萬人，佔65歲以上老人2%

表2-4　55 歲以上住機構者之機構類型-按年齡別

中華民國 111 年 10 月　　單位：人、%

	總計		長照機構	護理之家	榮民之家	身心障礙福利機構	失智及安養型機構
	人數	百分比					
總計	**97,643**	**100.00**	**48.45**	**38.35**	**6.39**	**3.74**	**3.07**
55-64 歲	13,274	100.00	22.39	57.43	2.59	17.36	0.23
65 歲以上	84,369	100.00	52.55	35.35	6.98	1.60	3.52

	總計		年齡			現有子女		婚姻	
	人數	百分比	55-64 歲	65-74 歲	75 歲以上	有子女	無子女	有偶	無偶
總計	**97,643**	**100.00**	**13.59**	**24.46**	**61.94**	**81.54**	**18.46**	**22.07**	**77.93**
55-64 歲	13,274	100.00	100.00	-	-	53.68	46.32	28.82	71.18
65 歲以上	84,369	100.00	-	28.31	71.69	85.92	14.08	21.01	78.99